금융위원회 / 금융감독원	보 도 자 료			한국판뉴딜 대한민국 대전환
	보도	2020.12.10.(목) 조간	배포	2020.12.9.(수)

책 임 자	금융위원회 보험과장 김 동 환(02-2100-2960)	담 당 자	금융위원회 보험과 사무관 남 명 호(02-2100-2963)
	금융감독원 보험감독국장 강 한 구(02-3145-7460)		금융감독원 특수보험2팀장 권 재 순(02-3145-7474)
	보험연구원 부원장 조 재 린(02-3775-9034)		보험연구원 손해보험연구실장 정 성 희(02-3775-9024)
	보험개발원 생명장기손해보험부문장 장 이 규(02-368-4105)		보험개발원 실손의료보험TF팀장 문 성 연(02-368-4343)
	생명보험협회 시장지원본부장 신 영 선(02-2262-6621)		생명보험협회 리스크관리지원부장 김 인 호(02-2262-6645)
	손해보험협회 손해보험1본부장 이 재 구(02-3702-8524)		손해보험협회 장기보험부장 박 기 준(02-3702-8531)

제 목 : 실손의료보험, 이용한 만큼 보험료를 내는 할인·할증 제도가 새로 도입됩니다. (제4세대 실손, 내년 7월 출시)

◈ **실손의료보험이 국민건강보험을 보완하는 사적(私的) 사회 안전망 역할을 지속 수행할 수 있도록, 상품구조를 전면 개편**

- **가입자간 보험료 부담의 형평성 제고(비급여 보험료 차등제*) 및 자기부담률 조정 등을 통한 도덕적 해이 방지**

  * 건강보험법상 산정특례대상자 등 **의료취약 계층**은 **차등제 적용 제외**

- **보장범위·한도는 기존과 유사하면서 국민의 보험료 부담은 기존 상품 대비 10~70% 대폭 인하***

  * 新실손 대비 **약 10%↓**, 표준화 실손 대비 **약 50%↓**, 표준화 前 실손 대비 **약 70%↓**

1 추진 배경

□ **실손의료보험**은 건강보험이 보장하지 않는 의료비를 보장하는 '국민의 **사적(私的) 사회 안전망**'으로서 **역할***을 수행해 왔습니다.

* '19년말 기준 약 3,800만명 가입(단체보험, 공제계약 포함)

○ 그러나, ‘99년 최초 상품 출시 당시 **자기부담금이 없는 100%보장 구조** 등으로 **과다** 의료서비스 **제공** 및 **이용**을 **유발**할 수 있는 **구조적 한계점**을 가지고 있었습니다.

□ **실손의료보험**은 그 동안 자기부담률 인상, 일부 비급여 과잉진료 항목의 특약* 분리 등 **지속적인 제도 개선**에도 **불구**하고,

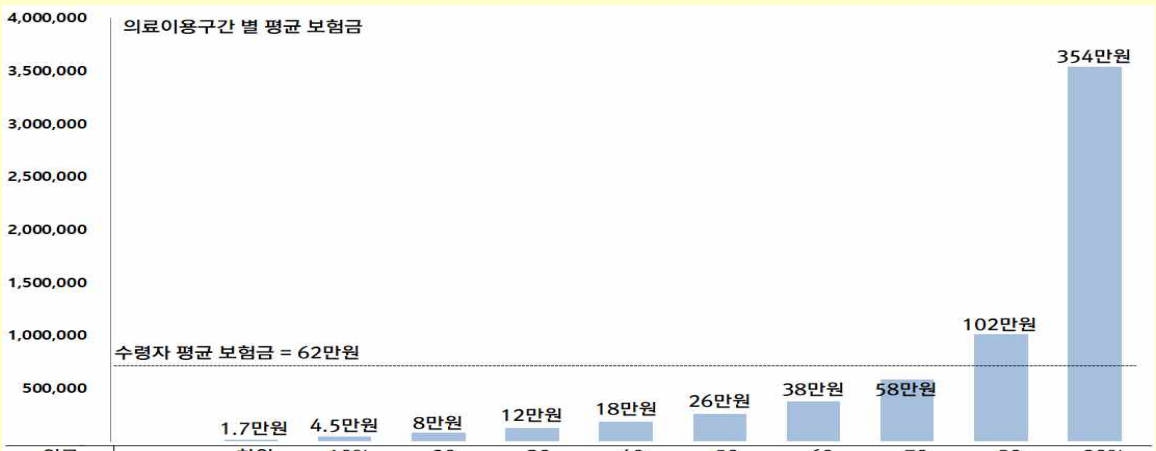
* 1)도수·증식·체외충격파 2)비급여 주사 3)비급여 MRI

○ 여전히 **극히 일부의 과다한** 의료서비스 **이용**으로 **대다수** 국민의 **보험료 부담**이 **가중**되고, 보험회사의 **손해율**이 **급격히 상승**하는 등 **많은 문제점**이 **지적**되고 있습니다.

≪ 현행 실손의료보험 제도 문제점 ≫

① 일부 가입자의 **과다 의료이용**이 **대다수 가입자**의 **보험료 부담**으로 **전가**

* 의료이용량 상위 10%가 전체 보험금의 56.8%를 지급받으며, 무사고자를 포함하여 전체의 가입자의 93.2%는 평균 보험금(62만원) 미만을 지급받음



의료 이용량	무사고자	하위 0~10%	10% ~20%	20 ~30%	30 ~40%	40 ~50%	50 ~60%	60 ~70%	70 ~80%	80 ~90%	90% ~100%
가입자 비중	65.7%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%
지급보험금 비중		0.3%	0.7%	1.3%	2.0%	2.9%	4.2%	6.1%	9.3%	16.3%	56.8%

* 생·손보 전체 실손의료보험(표준화 실손) 보험금 지급현황 (‘18년 기준)

② 지급보험금의 급격한 상승에 따른 국민의 **보험료 부담 증가**

구 분	‘14	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19	연평균 상승률
지급보험금 (조원)	4.9	5.6	7.0	7.5	8.7	11.0	**17.7% ↑**
1인당 지급보험금 (만원)	16.1	17.5	21.1	22.6	25.7	32.1	**14.7% ↑**

* 1인당 지급보험금의 상승은 1인당 실손 보험료 부담 증가로 이어짐

③ **적자 누적***으로 인한 보험회사의 실손의료보험 **판매 중지**** 및 **가입 심사 강화*****

* ('17년) -1.2조, ('18년) -1.2조, ('19년) -2.5조 ('20상) -1.3조 ⇒ **'17~'20년 누적 6.2조원**

** 기존 실손보험 판매 회사(30개사) 중 '19년말 기준 판매중지 회사는 모두 11개사 (생보 8개사, 손보 3개사)

*** "실손보험 들려면 피 뽑아 검사하라고?... 문턱 높이는 보험사" (ㅇㅇ일보, '20.2.13)
"팔아봐야 손해... 손보사, 20대 실손가입자까지 심사 강화" (ㅇㅇ신문, '20.1.8)

➜ **이러한 현상이 지속될 경우, 국민 의료비 부담이 가중되고, 실손의료보험의 지속가능성에 대한 심각한 우려도 제기되는 상황입니다.**

□ **실손의료보험**이 국민 의료비 부담을 경감하는 **'건강한' 사적(私的) 사회 안전망** 기능을 **지속 수행**할 수 있도록 상품 구조에 대한 **근본적인 개편**을 **추진**하게 되었습니다.

2 상품구조 개편 기본방향

◈ **보장범위·한도**는 기존과 **유사**, **보험료 수준**은 **대폭 인하**

◈ 보험료 상승의 **주(主)원인**인 **비급여**에 대해 ①**특약**으로 **분리**하고, ②**보험료 차등제**를 **도입**하여 **가입자간 보험료 부담 형평성 제고**

◈ 건강보험의 **보완형 상품**으로서의 **연계성 강화 (재가입주기 조정)**

3 주요 개편내용

(1) 보장범위·한도는 기존과 유사하면서 보험료 수준은 대폭 인하

[보장범위 및 한도]

□ 새로운 상품의 주계약(급여)과 특약(비급여)을 **모두 가입**할 경우,

○ **보장 범위**는 **종전과 동일**하게 대다수의 질병·상해 치료비를 **보장** 받을 수 있습니다.

- 질병·상해로 인한 입원과 통원의 **연간 보장한도**를 **기존과 유사**하게 **1억원 수준**(급여 5천만원, 비급여 5천만원)으로 책정*하였습니다.

* '19년 기준 5천만원 이상 보험금을 지급받은 사람은 전체 가입자의 0.005%

구분		현행 (단위: 만원)	⇒	보장한도 (단위: 만원)	
				급여	비급여
질병	입원	5,000		입·통원 합산 연간 5천만원 (통원 회당 20만원)	입·통원 합산 연간 5천만원 (통원 회당 20만원*)
	통원	5,400 (30만원×180회)			
상해	입원	5,000		입·통원 합산 연간 5천만원 (통원 회당 20만원)	입·통원 합산 연간 5천만원 (통원 회당 20만원*)
	통원	5,400 (30만원×180회)			

* 과다 의료서비스 제공 및 이용 소지가 높은 **비급여**에 한해 **별도 통원 횟수 제한 등 추가** 예정 (추후 표준약관에서 구체적으로 규정)

○ 다만, **적정한 의료서비스 제공 및 이용** 등을 위해 **자기부담금*** 수준 및 **통원 공제금액****이 종전에 비해 **높아집니다.**

* **(현행)** 급여 10/20%, 비급여 20% ➔ **(변경)** 급여 20%, 비급여 30%

** **(현행)** [급여, 비급여 **통합**] 외래 1~2만원, 처방 0.8만원
➔ **(변경)** [급여, 비급여 **구분**] 급여 1만원**(단, 상급·종합병원 2만원)** / 비급여 3만원

[보험료 수준]

□ **새로운 상품**은 자기부담금 수준과 통원 공제금액 **인상의 효과**로 **보험료**가 기존 상품보다 **대폭 낮아집니다.**

○ '17년 출시된 **新실손 대비 약 10%**, '09년 이후 **표준화 실손 대비 약 50%**, **표준화 前 실손 대비 약 70%** 정도 **인하**됩니다.

< 새로운 실손과 기존 실손과의 40세(남자) 기준 보험료 비교 (예시) >

상품종류	'20 보험료기준	새로운 실손과 비교	
		月 보험료 차이	年 보험료 차이
표준화 前	36,679	+25,750	+309,000
표준화 後	20,710	+9,781	+117,372
新실손	12,184	+1,255	+15,060
새로운 실손 (예상)	10,929	-	-

* 손해보험 4개사 보험료 평균

○ 기존 상품의 높은 손해율을 감안할 때, 기존 상품과의 보험료 격차는 향후 더 커질 것으로 예상됩니다.

< 기존 실손의료보험 상품의 위험손해율 비교 >

구 분	'16	'17	'18	'19
표준화 前 ('09 이전)	138%	131%	132%	144%
표준화 後 ('09 이후)	127%	116%	119%	135%
新실손 ('17.4월~)		59%	78%	100%

(2) 보험료 상승의 주(主)원인인 비급여를 특약으로 분리하고, 비급여 보험료 차등제를 도입하여 가입자간 보험료 부담의 형평성 제고

[비급여 특약 분리]

□ 현재의 포괄적 보장구조(급여+비급여)를 **급여 및 비급여로 분리**하여 **비급여 보장영역 관리**를 위한 **체계**를 **마련**하겠습니다.

현행 (新실손)	개편(안)
▸ 주계약 (급여+비급여)	▸ 주계약 (급여)
▸ 특약 (특정* 비급여) * 1)도수·증식·체외충격파 2)비급여 주사 3)비급여 MRI	▸ 특약 (비급여)

○ 이를 통해, 과다 의료서비스 제공 및 이용 소지가 큰 **비급여** 부분에 **보험료 차등제**를 **적용**할 수 있는 **기반**이 **마련**되고,

○ 급여, 비급여 **각각의 손해율**에 따라 **보험료**가 **조정**되어, **본인**의 **의료이용 행태 및 보험료 수준**에 대한 **이해도가 높아질 것***으로 기대됩니다.

* **보험료 인상 요인**이 '급여' 또는 '비급여' 때문인지 **명확**하게 **인식**

[비급여 보험료 차등제 도입]

□ 도수치료 등 **비급여**는 급여 대비 **의료관리체계**가 **미흡**하여,

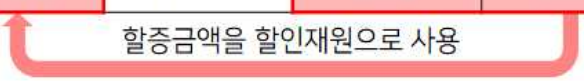
○ **일부 가입자**의 **비급여** 의료이용량이 **전체 가입자**의 **보험료 부담**으로 이어지는 **형평성 문제***가 **심각**합니다.

* 실손의료보험의 전체 지급보험금 중 비급여 비중은 65%(급여 35%) → 비급여 의료이용량의 변화가 전체(급여+비급여) 보험료에 미치는 영향이 큰 것을 의미함

□ **비급여** 의료이용량과 **연계**한 **보험료 차등제**를 **도입**하여, 가입자간 보험료 부담의 **형평성 문제**를 **해소**하겠습니다.

○ 할인·할증에 대한 가입자의 **이해도**를 **높이기 위해** 적용 단계는 **5등급**으로 **단순화**하였습니다.

구분	1등급 (할인)	2등급 (유지)	3등급 (할증)	4등급 (할증)	5등급 (할증)
할인/할증률	-5%[1]		+ 100%	+ 200%	+ 300%
비급여 지급보험금 (평균 지급보험금[2] 대비)	지급보험금 無	100만원 미만 (300% 미만)	150만원 미만 (500% 미만)	300만원 미만 (1,000% 미만)	300만원 이상 (1,000% 이상)
가입자 비중[3]	72.9%	25.3%	0.8%	0.7%	0.3%



1) **할인율**은 상품 출시 후, **회사별** 계약/사고 통계량에 따라 **5% 내외**로 **변동 가능**

2) 비급여 의료이용자의 평균 지급보험금은 **약 30만원**

3) 新실손 기준 시뮬레이션 결과, **할증**구간(3~5등급) 대상자는 **전체 가입자의 1.8%**

○ **할증 등급**이 **적용**되는 **가입자**는 **전체 가입자**의 **극소수(1.8%)**인 반면에, **대다수의 가입자**는 **보험료 할인 혜택**을 볼 수 있을 것으로 기대됩니다.

○ 충분한 통계확보 등을 위해 **할인·할증**은 새로운 상품 출시 후, **3년이 경과한 시점부터 적용**할 예정*입니다.

* 가입자 수, 청구건수가 충분히 확보되어야 통계적으로 안정된 할인·할증율 제공이 가능하며, 기존 **新실손의 가입 추이** 등을 고려할 때 **최소 3년의 준비기간**이 **필요**

□ **비급여 보험료 차등제**는 의료취약계층의 **의료 접근성**을 **제한**하지 **않도록** 하기 위해,

○ 지속적이고 충분한 치료가 필요한 **'불가피한 의료 이용자'***에 대해서는 **적용**을 **제외**하였습니다.

* 국민건강보험법상 **산정특례 대상자** (암질환, 심장질환, 희귀난치성질환자 등)
→ '18년 기준 전체 인구 수 대비 약 4%

* 노인장기요양보험법상 **장기요양대상자** 중 **1~2등급 판정자**(치매·뇌혈관성 질환 등)
→ '19년 기준 65세 이상 인구 수 대비 약 1.5%

(3) 국민건강보험의 보완형 상품으로서의 연계성 강화

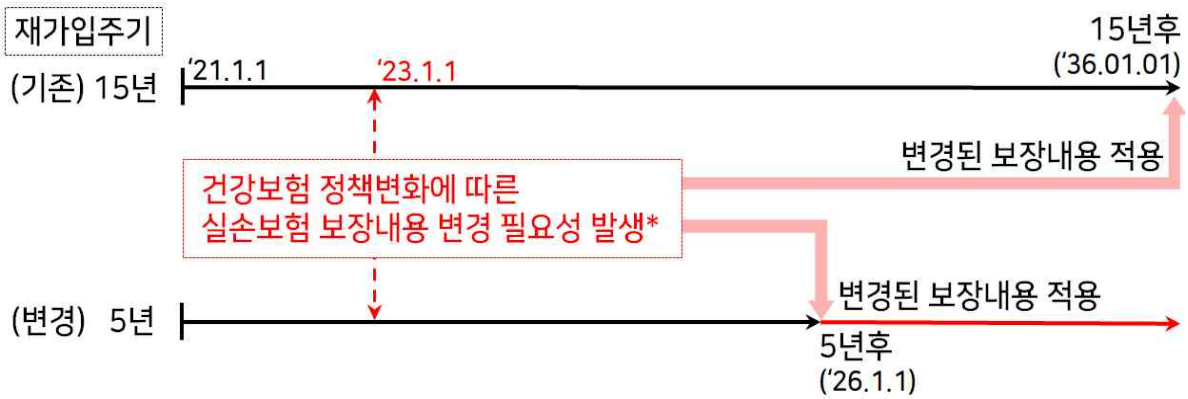
□ 실손의료보험은 건강보험의 **보완형 상품**으로서 건강보험 정책 방향에 **부합되게 운영**될 **필요**가 있으며,

○ 의료기술 발전, 진료행태 변화 등 **의료환경 변화**에도 **시의 적절하게 대응**할 **필요**가 있습니다.

□ 실손의료보험의 **재가입주기***를 15년에서 **5년**으로 **단축**하여,

* 실질적으로 **'보장내용 변경주기'**를 **의미**하며, 동일 보험사의 실손의료보험에 **再가입 時**, 과거 사고 이력 등을 이유로 **계약 인수를 거절하지 못함**

○ **건강보험정책**과의 **연계성을 강화***하고, 의료환경 변화에 **적절히 대응****할 수 있도록 하겠습니다.



* **[건강보험과 연계성 강화]** **건강보험**에서 非응급환자의 상급종합병원 응급실 이용시 **응급의료관리료**(6만원 내외)를 **환자가 전액 부담**토록 할 때, **실손의료보험**에서도 **이를 보장하지 않기** 위해 **보장내용(표준약관)**을 **변경**하려면 **15년이나 소요**

** **[의료환경 변화에 대응]** 재가입 주기 단축으로 **특정 질환**을 **신속**하게 **보장** 가능 (예 : '14년 출시된 노후실손의 경우, 재가입 주기(3년) 도래 시 보장내용이 확대 (정신질환 보장 추가))

4 상품구조 개편방안 (종합)

◈ **비급여 특약 분리 및 보험료 차등제 도입, 자기부담률 조정** 등으로 가입자의 **보험료 부담**이 **낮아지고**, 가입자간 **보험료 부담의 형평성**이 **제고**될 것으로 기대됩니다.

◈ 국민건강보험과의 **연계성 강화** 등으로 국민건강보험을 보완하는 **'건강한' 사적(私的) 사회 안전망 기능**을 **지속 수행**할 수 있을 것으로 기대됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>현행(新실손)</th><th></th><th>개편(안)</th></tr>
<tr><td colspan="2">상품구조</td><td>급여·비급여 통합
+ 비급여 3개 특약</td><td rowspan="2">⇒</td><td>급여(주계약)·비급여(특약) 분리</td></tr>
<tr><td rowspan="2">보험료
차등제</td><td>급여</td><td rowspan="2">미적용</td><td>미적용</td></tr>
<tr><td>비급여</td><td>적용 (할인·할증 방식)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">자기
부담률</td><td>급여</td><td>10% / 20%</td><td></td><td>20%</td></tr>
<tr><td>비급여</td><td>20%
(특약 : 30%)</td><td></td><td>30%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">공제
금액
(통원)</td><td>급여</td><td rowspan="2">최소 1~2만원
(처방 0.8만원)</td><td></td><td>최소 1만원(병·의원급) / 최소 2만원(상급·종합병원)</td></tr>
<tr><td>비급여</td><td></td><td>최소 3만원</td></tr>
<tr><td rowspan="2">보장
한도</td><td>입원</td><td>상해·질병당
연간 5천만원</td><td>⇒</td><td rowspan="2"><table><tr><th>구 분</th><th>급여</th><th>비급여</th></tr><tr><td>상해
입·통원</td><td>합산 연간 5천만원
(통원 회당 20만원)</td><td>합산 연간 5천만원
(통원 회당 20만원)*</td></tr><tr><td>질병
입·통원</td><td>합산 연간 5천만원
(통원 회당 20만원)</td><td>합산 연간 5천만원
(통원 회당 20만원)*</td></tr></table>* 비급여에 한해 별도 통원횟수 추가 예정</td></tr>
<tr><td>통원</td><td>상해·질병당
회당 30만원
(연 180회)</td></tr>
<tr><td colspan="2">재가입주기</td><td>15년</td><td></td><td>5년</td></tr>
</table>

5 향후 계획

□ **기존 실손 가입자**가 **원하는 경우***, 새로운 상품으로 **간편하게 전환**할 수 있는 **절차 마련**** (新상품 출시 前까지)

* 기존 상품에 비해 보험료가 저렴하지만, 보장내용, 자기부담금 등에 차이가 있으므로 **본인의 건강상태, 의료이용 성향 등**을 **고려**하여 **전환여부**를 **판단할 필요**

** 계약 전환을 위해 별도 심사가 필요한 경우만 **제한적**으로 **열거**(Negative 방식)하고, **그 외의 경우**는 **모두 무심사**로 **전환** 가능한 방안 검토

□ 보험업감독규정 및 보험업감독업무시행세칙 개정

① **('21.1월)** 보험업감독규정 **개정안 규정변경예고**

② **('21.1~4월)** 규제개혁위원회 **규제심사** 및 금융위 **의결**

③ **('21.4월)** 보험업감독업무시행세칙* **개정안 변경예고**

* 표준약관 및 표준사업방법서 상 세부내용 개정

④ **('21.7.1)** **제4세대 실손의료보험 상품 출시**

"혁신금융, 더 많은 기회 함께하는 성장"

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

☞ 본 자료를 인용 보도할 경우 출처를 표기해 주십시오.
http://www.fsc.go.kr

금융위원회 대 변 인
prfsc@korea.kr

1339 질병관리본부 콜센터

나부터 지키는 우리 모두의 건강 해외감염병 NOW